

ITEM 298 : TUMEUR DU COLON ET DU RECTUM

CANCER COLORECTAL

- Atteint le **colon** dans 60% des cas (sex ratio 1/1) et le **rectum** dans 40% des cas (avec une prédominance masculine 2/1)
- 3^{ème} cancer le plus fréquent = 40 000/an : en ↗ d'incidence depuis 20 ans, âge moyen au diagnostic = 70 ans, rare < 50 ans
- 2^{ème} cause de mortalité par cancer = 17 500/an : mortalité en baisse, taux de survie global à 5 ans = **60%**
- FdR : âge > 50 ans, tabac, alcool, alimentation riche en protéines, obésité, sédentarité, antécédents familiaux ou personnels

Dépistage	Risque moyen = 4%	= Population général : dépistage de masse par test immunologique de saignement occulte dans les selles tous les 2 ans entre 50 et 74 ans → coloscopie si positive (8% de cancer, 40% de polypes) - Positif : cancer colorectal ou autre saignement digestif (polype > 1 cm, MICI, ulcère...) - Meilleures que Hémocult® : meilleure sensibilité pour le dépistage de cancer et d'adénome, non positifé par l'alimentation (viande rouge, fruits crus), moins bonne spécificité (↗ nombre de coloscopies)		
	Risque élevé	Atcds d'adénome ≥ 1 cm ou avec contingents villex 1 ^{er} cas de cancer colorectal	→ Coloscopie à 3 ou 5 ans , puis tous les 5 ans si normale	
		- Atcd familial au 1 ^{er} degré : 1 cas de cancer colorectal < 60 ans ou 2 cas de cancer colorectal à tout âge	→ Coloscopie à 45 ans (ou 5 ans avant l'âge du diagnostic du cas index), puis tous les 5 ans	
		Maladie de Crohn ou RCH : étendue et évoluant depuis 7-10 ans ou avec cholangite sclérosante Acromégalie	→ Coloscopies itératives ± Avec chromo-endoscopie en cas de MICI	
	Risque très élevé	- Syndrome de Lynch (4% des cancers colorectaux) : risque = 70% des hommes et 40% des femmes - Polypose adénomateuse familiale - Syndrome de Peutz-Jeghers		
Diagnostic	SF	Cancer colique	= Situé en amont de la jonction recto-sigmoïdienne, à > 15 cm de la marge anale : - Très longtemps asymptomatique - AEG, douleurs abdominales, trouble du transit d'apparition ou de modification récente - Hémorragie digestive : anémie (colon droit surtout), méléna (si colon droit) et/ou rectorragies - Surinfection : symptomatologie mimant une sigmoïdite aiguë - Complication : occlusion aiguë, perforation, endocardite/septicémie à germe digestif (<i>S. bovis</i>), MT → Diagnostic : coloscopie avec biopsies	
		Cancer rectal	- Rectorragies - Syndrome rectal : faux besoins impérieux, émissions afécales glairo-sanglantes, épreintes, ténésme - Trouble du transit d'apparition/modification récente - Plus rarement : occlusion aiguë, anémie, découverte de métastase - TR en cas de cancer rectal moyen ou bas : siège, extension endoluminale, caractère mobile ou fixé → Diagnostic : rectoscopie au tube rigide ou coloscopie courte avec biopsies	
	SC	- Extension : ganglion de Troisier, TR, hépatomégalie , recherche d'ascite, recherche de carcinose péritonéale		
	Bilan	Systématique	- Coloscopie totale : recherche de lésions synchrones du rectum et du colon → En cas de sténose non franchissable : coloscopie dans les 6 mois après résection - Scanner thoraco-abdomino-pelvien (ou RP + écho abdo à défaut) : recherche de MT viscérales - Dosage de l'ACE (Ag carcino-embryonnaire) : pronostic et suivi - Bilan pré-thérapeutique : état général, état nutritionnel, bilan d'opérabilité	
		Cancer rectal	- Echo-endoscopie et/ou IRM pelvienne : extension pariétale, atteinte ganglionnaire	
Histo	Adénocarcinome : liberkühnnien dans la majorité des cas (75%), colloïde, mucineux - Classification TNM et stade AJCC : nécessite l'examen de ≥ 12 ganglions régionaux sur la pièce de colectomie - Détermination du statut tumoral : - RAS (KRAS et NRAS) si M+ : prédictif de la non-réponse aux anti-EGFR si muté - Mutation BRAF V600E : de mauvais pronostic (sans indication thérapeutique) - Recherche de phénotype MSI : si < 60 ans ou antécédent familial ou personnel de cancer du spectre HNPCC Autres (rares) : lymphome, carcinome épidermoïde, léiomyosarcome... → A la différence des autres organes, un cancer colorectal infiltrant uniquement la muqueuse est considéré <i>in situ</i>			
	Tis : intra-épithéliale ou intra-muqueux T1 : sous-muqueux T2 : musculuse T3 : sous-séreuse (colon), méso-rectum (rectum) T4 : 4a = séreuse = péritoine, 4b = organe voisin		N1a : 1 ADP régionale N1b : 2-3 ADP régionales N2a : 4-6 ADP régionales N2b : ≥ 7 ADP régionales	M1a : 1 MT (dont ADP sus-claviculaire, iliaque externe ou commune) M1b : plusieurs MT ou MT péritonéale

TTT	Cancer du colon non métastaté	Chirurgie	= Exérèse de la tumeur primitive avec marges de colon sain ≥ 5 cm avec exérèse des vaisseaux et du mésocolon contenant les ganglions lymphatiques (curage) - Possiblement sous coelioscopie - Hémi-colectomie (droite ou gauche) ou sigmoïdectomie $\pm$ étendue au rectum - Rétablissement immédiat de continuité		
		Chimiothérapie adjuvante	= FOLFOX = oxaliplatine + 5FU + acide folinique : pendant 6 mois - Indication formelle si stade 3 (N+) - Discuté si stade 2 selon le pronostic : stade IIA, B ou C, âge, nombre de ganglions examinés, phénotype MSI (de bon pronostic), différenciation...		
	Cancer du rectum non métastaté	Néo-adjuvant	= Radio-chimiothérapie ou radiothérapie néo-adjuvante : 45 Gy + 5-FU oral (capécitabine) - Intérêt dans les tumeurs du bas et du moyen rectum de stade T3-T4 et/ou N+		
		Chirurgie	= Conservation ou amputation du rectum et de l'anus : selon le siège de la tumeur $\rightarrow$ nécessité d'une marge d'amont ≥ 5 cm et d'une marge d'aval ≥ 1 cm - Curage mésentérique systématique $\rightarrow$ Tumeur T1N0 superficielle : possibilité de traitement trans-anal ou endoscopique		
			Haut rectum	10-15 cm de la marge anale	- Exérèse de la tumeur jusqu'à 5 cm sous le pôle inférieur - Exérèse totale du méso-rectum - Anastomose colo-rectale ou colo-anale
			Moyen rectum	5-10 cm de la marge anale	- Exérèse de la tumeur jusqu'à 5 cm sous le pôle inférieur - Stomie latérale temporaire avec anastomose colo-anale 2^{ndr} - Exérèse totale du méso-rectum
		Bas rectum	< 5 cm de la marge anale	- Proctectomie si possible (marge rectale distale > 2 cm) - Lésion très basse envahissant le sphincter anal ou distante de < 1 cm (soit < 4 cm de la marge anale) (après 2 nd avis) : amputation abdominopérinéale du rectum avec exérèse totale du méso-rectum et colostomie iliaque définitive	
	Adjuvant	= Chimiothérapie adjuvante (FOLFOX) : si tumeur stade III (N+)			
	TTT chirurgical des cancers colorectaux compliqués	$\rightarrow$ Intervention en urgence			
		Occlusion	- Colostomie 1^{ère} (le plus près possible en amont de la tumeur), puis résection-anastomose emmenant la colostomie dans un 2 nd temps à 8-15 jours - Colectomie subtotal (si caecum pré-perforatif) : lever de l'occlusion et traitement carcinologique en 1 temps - Traitement endoscopique ou radiologique si risque opératoire élevé : endoprothèse colique trans-tumorale suivie d'une chirurgie carcinologique quelques jours après - MT non résécable : - Prothèse définitive si soins de support exclusif - Stomie de décharge ou résection si chimiothérapie envisagée		
		Perforation	- Résection de la tumeur et de la zone perforée sans rétablissement immédiat de continuité avec 1 ou 2 stomies temporaires - Sous triple antibioprophylaxie IV (C3G + fluoroquinolone + aminoside)		
Surveillance	Clinique	- Examen clinique : tous les 3 mois pendant 2 ans puis tous les 6 mois pendant 3 ans			
	Radiologique	- Scanner-TAP ou écho + RP : tous les 3-6 mois pendant 2 ans puis 1/an pendant 3 ans			
	Endoscopique	- Coloscopie : - 2 à 3 ans après l'intervention puis tous les 5 ans si normale - A 6 mois si coloscopie initiale incomplète (occlusion...) - A 1 an si associée à ≥ 3 adénomes ou à 1 adénome avancé (> 1 cm, villex, dysplasie sévère, carcinome <i>in situ</i>) $\rightarrow$ Arrêt de la surveillance endoscopique si normale et bénéfice incertain (comorbidité sévère, sujet âgé > 80 ans, espérance de vie réduite...)			
	Autres	- Dosages répétés d'ACE : optionnel, recommandé si stade II-III - PET-scanner : si $\nearrow$ ACE avec bilan négatif			
Indication de consultation oncogénétique		- ≥ 2 antécédents familiaux de cancer du spectre HNPCC dont 1 < 50 ans - Antécédent personnel de cancer du spectre HNPCC - Cancer colorectal < 40 ans - Phénotype MSI +			

Cancer colorectal métastatique	Métastases : - 20 à 30% de métastase hépatique au diagnostic (métastase synchrone) - 30 à 40% de risque de métastase métachrone si absente initialement		
	TTT curatif	- Exérèse chirurgicale des métastases hépatiques = réalisable dans 10-25% des cas, selon des critères anatomiques, techniques et carcinologiques (le nombre n'est pas limitant) : tumorectomie, segmentectomie, lobectomie, hémi-hépatectomie, hépatectomie élargie ± traitement de certaines métastases par radiofréquence percutanée ou per-opératoire → En cas de métastase hépatique résécable : bilan par IRM hépatique + PET-scan systématique - MT pulmonaires : discuter chirurgie d'exérèse si isolées ou associées à des MT hépatiques résécables - Carcinose péritonéale : discuter chirurgie ± chimio-hyperthermie intra-péritonéale (CHIP) → Chimiothérapie néo-adjuvante ou adjuvante : améliore la survie, peut rendre résécables des métastases jugées initialement non résécables	
	TTT palliatif	Chimiothérapie ± Thérapie ciblée	→ Réduction de la masse tumorale dans 50% des cas, amélioration de la qualité de vie et allongement de la médiane de survie de 2 ans (en l'absence de MT résécable) - Chimiothérapie : FOLFIRINI (5-FU + oxaliplatine + irinotécan), FOLFOX, 5-FU orale (capécitabine) ± Thérapie ciblée associée : - Ac anti-EGFR = cetuximab, panitumumab : si RAS sauvage - Ac anti-VEGF = bevacizumab : si RAS muté - Evaluation à 2-3 mois : - Discuter la chirurgie si résécable - Réponse/stabilisation mais non résécable : poursuite de chimiothérapie ou pause thérapeutique (avec suivi tous les 2 mois)
		Traitement chirurgical de la tumeur primitive	- Si exérèse de MT : double résection du primitif et des MT hépatiques en 1 ou 2 temps - En l'absence de possibilité d'exérèse de MT : résection du primitif optionnelle, envisagée si symptomatique (syndrome rectal, obstruction, tumeur hémorragique) - Palliatif : - Hémostase endoscopique : thermo-coagulation, injections hémostatiques - Désobstruction : thermo-coagulation endoscopique, endoprothèse

TUMEUR COLORECTALE BENIGNE

- Caractéristiques : **sessile, pédiculé** ou **plan**, de nature **bénigne** ou **maligne**

Histologie	Polype adénomateux		= Polyadénome = adénome : prolifération des cellules des glandes de Lieberkühn - Adénome tubuleux (75%), tubulo-villeux (20%), villeux (5%) ou festonné - Prévalence élevée, ↗ avec l'âge (30% à 65 ans), prédominance masculine (2/1) - Risque de dysplasie (de bas grade puis haut grade = cancer intra-épithélial), puis de cancérisation → FdR de transformation néoplasique : nombre, taille > 1 cm, proportion de contingent villeux		
	- Polype hyperplasique = simple allongement des cryptes glandulaires dont le contour luminal prend un aspect festonné : prédominant dans le colon distal et le rectum, ↗ avec l'âge (25% à 50 ans) → aucun risque de dégénérescence - Polype juvénile : tubes kystiques développés dans le chorion, rares, le plus souvent unique, chez les enfants de 1-7 ans - Pseudo-polype inflammatoire : muqueuse et tissu de granulation, après cicatrisation d'ulcération de MICI				
Diagnostic	C	= Généralement asymptomatique , de découverte fortuite par coloscopie de dépistage - Saignement d'un polype volumineux : rectorragie, anémie ferriprive			
	PC	- Rectoscopie au tube rigide : sans préparation ou 1-2 lavement, explore le rectum et jusqu'au bas sigmoïde - Rectosigmoïdoscopie : après 1-2 lavements évacuateurs, explore le rectum et tout ou partie du sigmoïde - Coloscopie totale : réalisée sous AG ou sédation simple, précédée d'un régime sans résidu/fibres pendant 5 jours puis d'un lavage colique complet par 3-4L de PEG la veille, explore tout le colon ± dernières anses grêles → Risque de perforation colique (1/1000) ± Avec chromo-endoscopie (mise en évidence des reliefs) : recommandée en cas de syndrome de Lynch ou MICI - Coloscopie virtuelle (TDM après préparation colique) : validé pour la détection de polypes > 6 mm			
	Classification de Vienne	1 : aucune néoplasie 2 : néoplasie indéfinie 3 : néoplasie de bas grade	4 : néoplasie de haut grade 4-1 : dysplasie de haut grade 4-2 : cancer in situ	4-3 : suspicion de cancer invasif 4-4 : cancer intra-muqueux 5 : infiltration de la sous-muqueuse	
TTT	- Polypectomie endoscopique : tout polype découvert doit être traité au cours de la coloscopie par destruction à la pince (polype très petit) ou ablation à l'anse diathermique ± mucosectomie (facilite l'exérèse des polypes sessiles) - Exérèse chirurgicale = colectomie segmentaire : indiquée si polypectomie endoscopique impossible - Examen histologique systématique de la pièce de polypectomie (ou des biopsies à défaut) : type histologique, degré de dysplasie, envahissement de la sous-muqueuse si malin - Résection colique segmentaire en cas d'histologie défavorable ou d'envahissement des marges de section				
	Surveillance après exérèse	= Coloscopie de contrôle : - A 3 ans si : adénome > 1 cm, ≥ 2 adénomes ou dysplasie de haut grade - A 5 ans sinon, puis tous les 5 ans → Seules les polypes adénomateux justifient une surveillance coloscopique → Surveillance interrompue si ne prolonge pas l'espérance de vie			
	Si transformation cancéreuse limitée	= Exérèse chirurgicale systématique, sauf si toutes les conditions sont réunies : - Aucune atteinte de la sous-muqueuse - Exérèse complète avec marge de sécurité ≥ 1 mm - Cancer bien ou moyennement différencié - Absence d'embolie lymphatique sous-muqueux			
	Autres types histologiques	- Coloscopie à 5 ans si ≥ 5 polypes hyperplasiques ou polype de taille ≥ 1 cm - Aucune surveillance coloscopique si polype inflammatoire ou juvénile			
POLYPOSE	Polypose adénomateuse familiale		= Mutation constitutionnelle du gène APC (K5) : maladie héréditaire autosomique dominante, de pénétrance quasi-complète → 1% des cancers colorectaux - Forme classique : > 100 polypes → cancérisation inéluctable < 40 ans - Colectomie totale ou coloproctectomie préventive indiquée vers 15 à 25 ans		
	Autres tumeurs associées		- Adénomes duodénaux (notamment péri-ampullaire) : à dépister par endoscopie digestive haute → duodéno-pancréatectomie céphalique si dégénérescence - Tumeurs desmoïdes (mésenchymateuse) : bénigne, mortalité par compression des organes avoisinants (notamment mésentérique)		
	Autres		- Syndrome de Peutz-Jeghers : polypes hamartomateux et pigmentation cutanéomuqueuse, risque de cancer du colon, de l'intestin grêle, du pancréas et de l'ovaire - Maladie de Cowden : hamartomes multiples, risque cancer du sein et de la thyroïde, plus rarement intestinal - Syndrome MAP (MYH associated polyposis) = forme atténuée de PAF : transmission autosomique récessive, polypes moins nombreux, de révélation tardive, 50% de cancérisation → chirurgie préventive selon le nombre - Polypose juvénile : hamartomes colorectaux fréquents → 40% de risque de cancer colorectal - Polypose hyperplasique ou mixte : risque de cancer colorectal des contingents adénomateux		